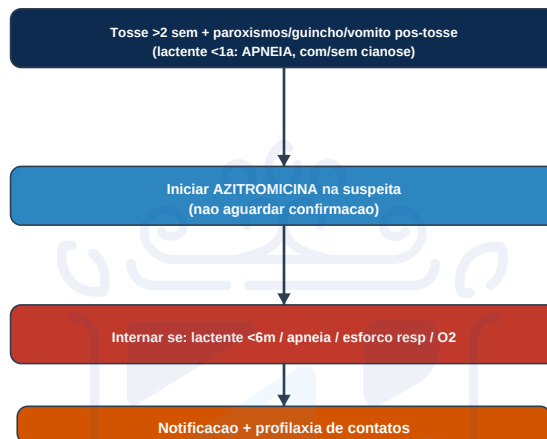


COQUELUCHE — TOSSE + GUINCHO + AZITRO

FLUXOGRAMA — ABORDAGEM

COQUELUCHE — TOSSE PROLONGADA -> AZITROMICINA



DEFINIÇÃO E QUADRO CLÍNICO

AS TRÊS FASES

- Agente: Bordetella pertussis; transmissão por gotículas respiratórias
- Fase CATARRAL (1-2 semanas): febre baixa, coriza, espirros, tosse — fase mais transmissível
- Fase PAROXÍSTICA (2-6 semanas): paroxismos de tosse, GUINCHO inspiratório após o acesso, vômitos pós-tosse, hemorragias conjuntivais/petéquias na face
- Fase de CONVALESCENÇA: tosse residual (pode durar até 3 meses)
- LACTENTE < 1 ano: pode apresentar APNEIA (com ou sem cianose) em vez de guincho — sinal de alarme

AValiação e diagnóstico

CRITÉRIO CLÍNICO

- Suspeita: tosse > 2 semanas + ≥ 1 de: tosse paroxística, guincho inspiratório, vômitos pós-tosse, ou apneia em < 1 ano
- Anamnese: contato com casos suspeitos/confirmados; situação vacinal
- Exame: sinais vitais, esforço respiratório, ausculta cardiopulmonar
- Laboratório: hemograma com LEUCOCITOSE e LINFOCITOSE; PCR/cultura para Bordetella
- RX de tórax: pode mostrar 'coração felpudo' (infiltrado peri-hilar)

TRATAMENTO — INICIAR NA SUSPEITA

Rx MACROLÍDEO É A 1ª LINHA

NÃO aguardar a confirmação laboratorial para iniciar o tratamento na suspeita clínica

1ª linha — AZITROMICINA: adultos 500 mg no 1º dia + 250 mg/dia do 2º ao 5º; crianças > 6 meses 10 mg/kg no 1º dia (máx 500) + 5 mg/kg/dia (máx 250) do 2º ao 5º (ou 10 mg/kg/dia por 5 dias)

Alternativa — Claritromicina: adultos 500 mg 12/12h por 7 dias; crianças 15 mg/kg/dia em 2 doses por 7 dias (não em < 1 mês)

Alternativa — SMX-TMP: adultos 800/160 mg 12/12h por 14 dias; crianças > 2 meses 8 mg/kg/dia de TMP por 14 dias (contraindicado < 2 meses)

Sintomáticos: Dipirona se dor/febre; o antibiótico precoce reduz a transmissão (mas pouco altera os paroxismos se já instalados)

INTERNAÇÃO, PROFILAXIA E NOTIFICAÇÃO

CONDUTA

- INTERNAR: instabilidade hemodinâmica, necessidade de O2 suplementar, sinais de esforço respiratório, lactente < 6 meses, APNEIA
- Lactentes pequenos têm maior risco de complicações graves (apneia, pneumonia, hipertensão pulmonar) — vigilância em UTI quando indicado
- Profilaxia dos CONTATOS próximos com o mesmo macrolídeo (azitromicina), independentemente da vacinação, sobretudo lactentes e gestantes
- Notificação compulsória; verificar e atualizar o esquema vacinal (DTP/dTpa)
- Isolamento respiratório por gotículas até 5 dias de antibiótico eficaz

ALTA E ORIENTAÇÕES

AMBULATORIAL

- ☐ ALTA: estável, sem esforço respiratório, sem apneia, aceitando VO, antibiótico iniciado, família orientada
- ☐ Receita exemplo (adulto): Azitromicina 500 mg (3 comp) — 1 cp no 1º dia e 1/2 cp do 2º ao 5º; Dipirona 1 g 6/6h se dor/febre
- ☐ Orientar que a tosse residual pode durar semanas a meses (convalescença)
- ☐ Retorno imediato: apneia/cianose, esforço respiratório, recusa alimentar, piora geral (sobretudo lactentes)
- ☐ Reforçar vacinação de contatos e da gestante (dTpa)

MODELO DE REGULAÇÃO / TRANSFERÊNCIA

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Paciente ____ (idade) com suspeita de coqueluche; tosse há ____ dias, fase ____ (paroxística), com guincho/vômitos/APNEIA ____; vacinação ____; contato prévio ____.
- Exame: estado geral ____, cianose ____, SpO2 ____, esforço respiratório ____; ausculta ____.
- Hemograma: leucócitos ____ / linfócitos ____ (linfocitose?); RX: ____ (coração felpudo?).
- Conduta: O2 ____, Azitromicina iniciada; solicito internação/UTI (lactente < 6m / apneia / insuficiência respiratória).

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Qual achado clínico é característico da fase paroxística da coqueluche?

- A) Tosse com guincho inspiratório e vômitos pós-tosse
- B) Estridor laríngeo contínuo
- C) Sibilância expiratória isolada
- D) Tosse ladrante
- E) Apenas coriza

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é a manifestação típica da coqueluche em lactentes < 1 ano, em vez do guincho?

- A) Exantema
- B) Apneia (com ou sem cianose)
- C) Diarreia
- D) Artralgia
- E) Icterícia

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Qual é o antibiótico de primeira linha para a coqueluche?

- A) Amoxicilina
- B) Azitromicina (macrolídeo)
- C) Ceftriaxona
- D) Penicilina G
- E) Vancomicina

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Qual alteração no hemograma sugere coqueluche?

- A) Leucopenia com neutrofilia
- B) Leucocitose com linfocitose
- C) Eosinofilia isolada
- D) Plaquetopenia grave
- E) Anemia macrocítica

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Sobre os contatos próximos de um caso de coqueluche, é correto:

- A) Não há necessidade de qualquer medida
- B) Indicar quimioprofilaxia com macrolídeo, sobretudo lactentes e gestantes, e atualizar vacinação
- C) Apenas isolar o caso
- D) Tratar só se sintomáticos com cultura positiva
- E) Vacinar somente após 1 mês

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: A

Na fase paroxística há paroxismos de tosse seguidos de guincho inspiratório e vômitos pós-tosse, podendo cursar com hemorragias conjuntivais/petéquias na face.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

Em lactentes < 1 ano, a coqueluche pode se manifestar com APNEIA (com ou sem cianose) em vez do guincho — sinal de alarme que indica internação.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

A azitromicina (macrolídeo) é a 1ª linha; alternativas são claritromicina e SMX-TMP. Iniciar na suspeita, sem aguardar confirmação.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

A coqueluche cursa tipicamente com leucocitose e linfocitose no hemograma.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Os contatos próximos recebem quimioprofilaxia com macrolídeo (sobretudo lactentes e gestantes), com atualização do esquema vacinal; o caso é de notificação compulsória.

SM24
Suporte ao Plantão Médico